BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN Phòng Điều dưỡng	QUY TRÌNH CHUẨN (SOP) PHÂN LOẠI ƯU TIÊN NGƯỜI BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH	Mã số: SOP-A4.1-01 Lần ban hành: 01 Ngày hiệu lực: …/…/2026 Số trang: theo bản in

	Người biên soạn	Người kiểm tra	Người phê duyệt
Họ tên			
Chức danh	Điều dưỡng Phòng Điều dưỡng	Trưởng phòng Điều dưỡng	Giám đốc
Chữ ký			
Ngày			

Lần	Ngày	Nội dung sửa đổi
01		Ban hành lần đầu; áp dụng cùng Quy trình nhận định người bệnh tại khoa Khám bệnh (QTKT.KKB.02)

DỰ THẢO

1. Mục đích

Phát hiện sớm người bệnh nặng ngay khi đến khám, xếp đúng mức ưu tiên, không để người bệnh nguy hiểm phải chờ theo số.

2. Phạm vi

Điều dưỡng phân loại tại sảnh, khu đăng ký và khu chờ Khoa Khám bệnh; áp dụng trong giờ hành chính. Ngoài giờ, người bệnh đến Khoa Cấp cứu.

3. Các bước thực hiện

Bước	Nội dung	Thời điểm
1. Quan sát nhanh	Quan sát người bệnh khi đến: tri giác, thở, màu da, đi lại; hỏi lý do đến khám	Ngay khi đến
2. Hỏi dấu hiệu nguy hiểm	Đối chiếu danh sách mục 4; có bất kỳ dấu hiệu nào thì xếp Đỏ	Trong 2–3 phút
3. Đo dấu hiệu sinh tồn	Mạch, huyết áp, nhịp thở, SpO2, nhiệt độ cho người bệnh có triệu chứng, người cao tuổi, trẻ nhỏ	Trước khi xếp mức Vàng, Xanh
4. Xếp mức và xử trí	Đỏ: chuyển Khoa Cấp cứu bằng xe hoặc cáng, có nhân viên đi kèm, báo trước bằng điện thoại. Vàng: xếp lượt ưu tiên. Xanh: đăng ký theo số	Ngay
5. Đau ngực	Ghi điện tim trong 10 phút kể từ khi đến, đưa bác sĩ đọc ngay; không để người bệnh tự cầm kết quả đi chờ	≤ 10 phút
6. Đánh giá lại khi chờ	Người bệnh Vàng chờ quá 30 phút hoặc than mệt hơn: đo lại dấu hiệu sinh tồn, xếp lại mức	Mỗi 30 phút
7. Ghi nhận	Ghi BM-A4.1-02: giờ đến, mức phân loại, giờ được khám	Ngay

Bước	Nội dung	Thời điểm
	hoặc chuyển cấp cứu	

4. Dấu hiệu nguy hiểm (xếp mức Đỏ)

- Lơ mơ, hôn mê, co giật; yếu liệt nửa người, méo miệng, nói khó mới xuất hiện.
- Khó thở, thở rít, tím; SpO2 < 92% khí trời (mốc đề xuất).
- Đau ngực, đau bụng dữ dội; chảy máu nhiều; nôn ra máu, đi cầu ra máu.
- Mạch < 40 hoặc > 130 lần/phút; huyết áp tâm thu < 90 mmHg (mốc đề xuất).
- Sốt cao kèm lừ đừ ở trẻ dưới 3 tháng; phụ nữ có thai đau bụng, ra huyết.
- Chấn thương nặng; ngộ độc; phản ứng dị ứng có khó thở.

Ghi chú: *Ngưỡng sinh hiệu ở mục 4 là mốc đề xuất để Hội đồng chuyên môn duyệt. Người bệnh không giao tiếp được (người nước ngoài, khiếm thính) phải được đo dấu hiệu sinh tồn, không dựa vào lời kể (bài học sự cố 28/03/2026).*

5. Tiêu chuẩn đánh giá

- KPI-A4.1-04: Tỷ lệ NB phân loại mức Đỏ được xử trí ngay ≥ 95%.
- KPI-A4.1-05: Tỷ lệ NB đau ngực được ghi điện tim trong 10 phút ≥ 90%.

6. Căn cứ

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 (Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH).
- Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện.
- Quyết định số 79/QĐ-BYT ngày 09/01/2026 hướng dẫn chỉ định nhập viện người bệnh cấp cứu.
- Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 (Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam).